

Nierówności dochodów w krajach a międzykulturowe różnice w całowaniu w usta¹

Christopher D Watkins¹, Juan David Leongómez², Jeanne Bove³, Agnieszka Żelaźniewicz⁴, Max Korbmacher¹, Marco Antônio Corrêa Varella⁵, Ana Maria Fernandez⁶, Danielle Wagstaff⁷ & Samuela Bolgan¹

1 Abertay University, 2 Universidad El Bosque, 3 IAS Toulouse, 4 University of Wrocław, 5 University of Sao Paulo, 6 University of Santiago, 7 Federation University Australia

Pytanie badawcze

Pocałunki romantyczne są powszechnym zwyczajem, ale nie są obserwowane we wszystkich znanych kulturach². Jeżeli pocałunki odgrywają rolę w „ocenie partnera” (np. jego zdrowia) i/lub podtrzymania długoterminowego związku³⁻⁴, postawy i zachowania związane z całowaniem powinny zależeć od poziomu zdrowia i zasobności społeczeństwa (np. zdrowie/długoterminowa inwestycja w związek mogą być ważniejsze w niektórych środowiskach w porównaniu do innych⁵⁻⁷)



Wyniki i wnioski

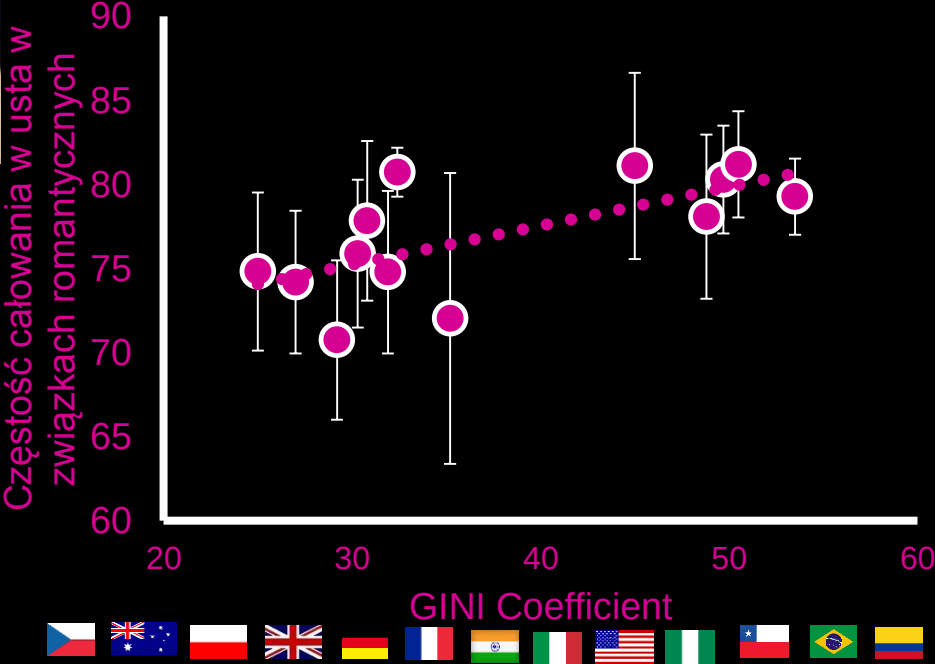
Uczestnicy postrzegali całowanie jako ważniejsze w stałych związkach w porównaniu do okresu załotów. Wyniki również pokazały, że ludzie częściej przytulają swoich partnerów w biedniejszych/zdrowszych narodach

Zgodnie z hipotezą, ludzie mieszkający w krajach o wysokich nierównościach dochodów częściej całują się z partnerem, w porównaniu do ludzi, zamieszkujących obszary o niskich nierównościach dochodów

Wyróżniono dwa komponenty dobrego pocałunku – „technika, kontakt i podniecenie” oraz „czynniki zmysłowe”. Czynniki zmysłowe jest ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn, a przyjemny oddech został wskazany jako najważniejszy z tych czynników

Metody

Uczestnicy (pochodzący z 13 krajów, 6 kontynentów) wypełnili kwestionariusz, dotyczący pocałunków w usta. W kwestionariuszu pytano o postawy (znaczenie pocałunków w fazie załotów i stałych związkach i zadowolenie z ilości całowania), częstość całowania i znaczenie siedmiu wybranych czynników w ocenie czy druga osoba „dobrze całuje”³⁻⁴. Podobne pytania dotyczyły przytulania/pieszczot (bez całowania) oraz stosunków płciowych. Odpowiedzi były analizowane w zależności od wskaźników zdrowia narodowego⁸ oraz dobrobytu (PKB i GINI)



[1] Watkins et al. (in press). *Sci Rep*. [2] Jankowiak et al. (2015). *Am Anthropol*, 117, 535-539. [3] Włodarski & Dunbar (2013). *Arch Sex Behav*, 42, 1415-1423. [4] Włodarski & Dunbar (2013). *Hum Nat*, 24, 402-413. [5] Tybur & Leiber (2016). *Curr Opin Psychol*, 7, 6-11. [6] Miller & Maner (2012). *J Person Soc Psychol*, 102, 1198-1213. [7] Gangestad & Simpson (2000). *Behav Brain Sci*, 23, 675-687. [8] Murray & Schaller (2010). *J Cross Cult Psychol*, 41, 99-108.